

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Las Unidades de Quemados son departamentos incluidos en los hospitales en los cuales, gracias a una infraestructura de medios y de personal muy específicos, están capacitados para la admisión y manejo de cualquier paciente que presente quemaduras, desde las más simples a las que precisen atención específica. En España existen varios hospitales capacitados para el tratamiento de pacientes con quemaduras, pero sólo existen 8 Unidades de Grandes Quemados distinguidas con el certificado CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para el manejo de grandes quemados.

Estos Hospitales son:

- Hospital Universitario La Paz, Madrid
- Hospital Universitario de Getafe, Madrid
- Hospital Universitario Valle de Hebrón, Barcelona
- Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
- Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
- Complejo Universitario Hospitalario de A Coruña
- Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
- Hospital Universitario Cruces, Bilbao

DIAGNÓSTICO:

Criterios de traslado a una Unidad de Quemados (UGQ)

Los pacientes que presenten alguno de estos criterios pueden ser derivados a un hospital que atienda a pacientes quemados o directamente a una Unidad de Grandes Quemados:

- Quemaduras de 2º grado > del 10% SCQT.
- Quemaduras de cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones principales.
- Quemaduras de 3er grado.
- Quemaduras eléctricas de alto voltaje (incluyendo de rayos).
- Quemaduras químicas.
- Lesión por inhalación o por daño en la vía aérea.
- Quemaduras acompañadas de condiciones médicas preexistentes.
- Quemaduras acompañadas de trauma, cuando la quemadura posea el más alto riesgo de mortalidad o morbilidad.
- Quemaduras en niños donde no hay hospitales pediátricos.
- Pacientes con necesidades especiales, sociales o emocionales.

Es **candidato a ingreso** en la UGQ todo paciente adulto que:

- Requiera medidas de resucitación (hídricas, respiratoria, etc.).
- Precise monitorización constante.
- Precise curas con sedación intravenosa (i.v.) cada 12 horas.

Son **indicaciones absolutas** para efectuar ingreso en UGQ, pacientes con:

- Quemaduras en adultos de cualquier profundidad con STQ $\geq$ 20%

- Quemaduras en adulto de cualquier extensión y profundidad asociadas con inhalación de humos.
- Quemaduras en adulto eléctricas de alto voltaje con signos de rabdomiolisis.
- Quemaduras de 2° grado > del 10% SCQT, cuando se asocian a trauma severo, por ejemplo, por explosión o caída de altura.

Requieren valoración personalizada los pacientes adultos que presenten:

- Quemaduras dérmicas profundas, totales o subdérmicas $\geq 10\%$ y $< 20\%$.
- Quemaduras eléctricas.
- Quemaduras químicas.
- Quemaduras en zonas críticas.
- Quemaduras en paciente con lesiones asociadas (traumatismos, etc.).
- Quemaduras en paciente con riesgos asociados (cardiopatía, broncopatía, enfermedad metabólica, inmunodepresión, etc.).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Estabilización para el transporte ABC:
 - Ayuda respiratoria:
 - Evaluar las vías aéreas superiores por una posible obstrucción
 - Evaluar las vías aéreas inferiores
 - Máscara de O₂ al 100 % o intubación si estuviera indicado
 - Ayuda circulatoria:
 - Asegurar pulso.
 - Identificar y controlar hemorragia.
 - Colocar acceso intravenoso de calibre grueso, si posible en zona no quemada.
 - Iniciar infusión de líquidos según fórmula elegida.
 - Insertar catéter urinario y medir diuresis horaria:
 - Adultos: 30 – 50 ml/h.
 - Niños <30 kg: 1 ml/kg/h.
 - Quemadura eléctrica: 75 – 100 ml/h.
 - Cuidado de la herida:
 - Cubrir con sábanas limpias y secas.
 - Protección para evitar pérdida de calor:
 - Usar mantas térmicas aislantes.
 - No utilizar sábanas o vendajes mojados.
 - No retrasar traslado para hacer curas oclusivas o desbridamientos
 - Manejo del dolor:
 - Pequeñas dosis de opiáceos por vía intravenosa.
 - Control respiratorio por efecto sedante.
 - Dosis influenciada por lesión coexistente o enfermedad previa.
 - Valorar también suma de stress y dolor físico.

Cuando se trate de realizar una derivación de un paciente quemado a una unidad, debe intentar darse la mayor información posible al profesional que reciba el aviso. Esta información debe contener al menos estos ítems:

- Causa de la quemadura, lo más detallada posible.
- Superficie aproximada de la quemadura, si es posible indicando si existen zonas dérmico-

profundas.

- Si el accidente ha ocurrido en lugar cerrado, o existe sospecha de inhalación de humos o de lesión de vía aérea por calor. En caso de que se decida intubación en el lugar del suceso, debe avisarse.
- Existencia o sospecha de trauma asociado.
- Sexo, edad y antecedentes médicos de relevancia del paciente, si ello es posible.
- Modo de traslado del paciente.

La decisión del traslado es una colaboración entre los médicos que atienden al paciente y el centro de referencia para quemados.

BIBLIOGRAFÍA

- Gonzalez Caverro-J, Arévalo Velasco-JM, Lorente-JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999(11) 295-301.
- Bittner EA, Shank E, Woodson L, Jeevendra Martyn JA. Acute and Perioperative Care of the Burn-injured Patient. Anesthesiology 2015; 122:448-64
- Lorente-JA; Esteban-A. cuidados intensivos del paciente quemado. Springer-Berlag.1996.